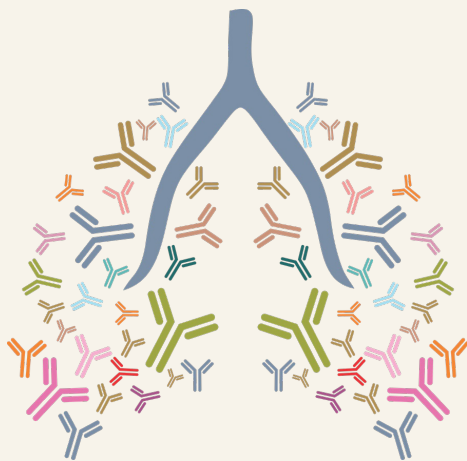




GUIA ILUSTRADO PARA PAIS

Pneumonia na Infância

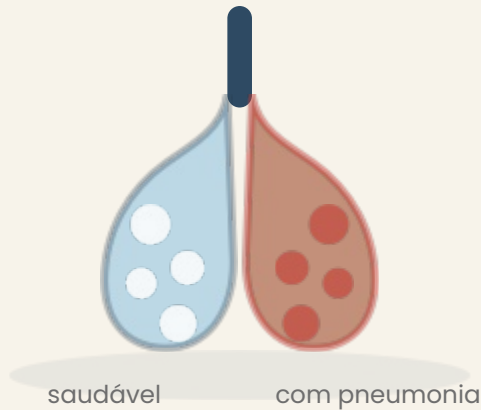
Quando suspeitar, quando correr,
e como cuidar em casa

Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751 • RQE 6271

O que é a pneumonia



Os pulmões são formados por milhões de bolsinhas de ar, os **alvéolos**, onde o oxigênio entra no sangue. Na pneumonia, uma infecção inflama essas bolsinhas e as enche de secreção.

Com parte do pulmão ocupada, a criança precisa **respirar mais rápido** para conseguir o mesmo oxigênio — por isso a respiração acelerada é um sinal tão importante.

Vírus ou bactéria?

Os dois podem causar pneumonia. Em bebês e crianças pequenas os **vírus são a causa mais comum**; as bactérias são mais frequentes conforme a criança cresce. Só o médico, examinando a criança, pode definir se há indicação de antibiótico.

Quando suspeitar



Desconfie de pneumonia quando houver **febre e tosse acompanhadas de respiração rápida**. A respiração acelerada é o sinal isolado mais confiável.

Como contar a respiração em casa

Com a criança **calma e sem febre**, observe o peito subir e descer durante **1 minuto inteiro**. É rápido demais se passar de:

Menores de 2 meses	acima de 60 por minuto
2 a 12 meses	acima de 50 por minuto
1 a 5 anos	acima de 40 por minuto
Acima de 5 anos	acima de 30 por minuto

Em bebês pequenos os sinais podem ser diferentes: gemido, recusa do peito ou da mamadeira, moleza, vômitos, barriga estufada ou até temperatura baixa — sem tosse chamativa.

Chiado no peito costuma apontar para outras causas, como bronquiolite ou asma. Quem diferencia é o exame médico.

NÃO ESPERE

Ir ao pronto-socorro agora



Diante de **qualquer um** destes sinais, leve a criança para atendimento imediato:

- ! Respiração muito rápida ou **difícil**: afundamento entre as costelas ou abaixo delas, batimento das asas do nariz, gemido a cada respiração
- ! Lábios, língua ou rosto **arroxeados**
- ! Pausas na respiração (apneia)
- ! Criança **muito prostrada**, largada, difícil de acordar ou irritada demais
- ! **Recusa de líquidos**, vômitos repetidos ou sinais de desidratação
- ! **Bebê com menos de 3 meses** com febre ou respiração rápida
- ! Convulsão, confusão ou desmaio
- ! Dor no peito forte, ou piora rápida em poucas horas

Nesses casos não tente ajustar remédios em casa nem aguardar a próxima consulta: a criança precisa ser examinada agora.

Quando dá para aguardar a consulta

Se a criança tem febre e tosse, mas **nenhum sinal da página anterior**, geralmente é seguro procurar atendimento ambulatorial nas próximas horas. Sinais tranquilizadores:

- ✓ Está **ativa**, brincando ou interagindo nos períodos sem febre
- ✓ **Bebe líquidos** e aceita alimentação, mesmo que menos que o habitual
- ✓ Respira **sem esforço**, com frequência dentro do esperado para a idade
- ✓ A febre **cede com o antitérmico** e a criança melhora quando a temperatura baixa
- ✓ Não tem doença de base respiratória, cardíaca ou imunológica

Atenção: aguardar não significa deixar de avaliar. Toda criança com suspeita de pneumonia precisa ser **examinada por um médico** — o que muda é a urgência.

Reavalie a criança várias vezes ao dia. Quadros respiratórios podem mudar rápido.

Sinais de que o antibiótico está agindo



A resposta ao antibiótico é avaliada em **48 a 72 horas**. Por isso o retorno costuma ser marcado nesse intervalo.



A febre cede

Costuma diminuir ou desaparecer em **48 a 72 horas** de antibiótico. É o principal sinal de resposta.



O apetite volta

A criança volta a aceitar líquidos e comida, mesmo que aos poucos.



Fica mais ativa

Volta a brincar, interagir e demonstrar disposição entre um pico de febre e outro.



A respiração acalma

A frequência respiratória cai e o esforço para respirar diminui.



Dorme melhor

Noites mais tranquilas, com menos despertares.

A tosse é a última a ir embora. Ela pode durar **2 a 4 semanas** mesmo com a pneumonia já curada. Tosse que persiste, sozinha, não significa que o tratamento falhou.

Complete todos os dias de antibiótico prescritos, mesmo com a criança bem.

Sinais de piora

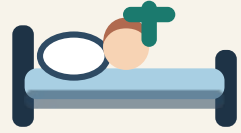
Estes sinais indicam que o tratamento pode não estar funcionando ou que surgiu uma **complicação**, como líquido ao redor do pulmão:

- ↓ A febre **não cede após 48 a 72 horas** de antibiótico
- ↓ A febre **volta** depois de já ter passado por um ou dois dias
- ↓ A respiração fica **mais rápida ou mais difícil**
- ↓ Aparece **dor no peito**, principalmente ao respirar fundo
- ↓ A criança fica **mais parada, sonolenta** ou sem interesse em brincar
- ↓ **Recusa líquidos** ou vomita o antibiótico repetidamente
- ↓ Surge **chiado, gemido** ou afundamento das costelas

Não espere o dia do retorno e **não troque o antibiótico por conta própria**. Procure reavaliação: pode ser necessário exame de imagem ou mudança de tratamento.

Uma pneumonia que não melhora no prazo esperado merece investigação – e não simplesmente mais tempo de espera.

Quando a internação é indicada



A maioria das pneumonias é tratada em casa. A internação entra quando a criança precisa de **oxigênio, soro ou antibiótico na veia**, ou de observação de perto:

- **Oxigênio baixo** no sangue, medido pelo oxímetro
- Desconforto respiratório **moderado a grave**: gemido, afundamento das costelas, asas do nariz, apneia
- Respiração muito acelerada para a idade
- **Desidratação** ou incapacidade de manter líquidos e alimentação pela boca
- Vômitos que impedem o uso do antibiótico oral
- Aparência de criança **gravemente doente**
- **Bebês pequenos**, especialmente abaixo de 2 a 3 meses
- **Doenças de base**: cardíacas, pulmonares, neurológicas, genéticas ou imunológicas
- **Complicações**, como derrame pleural (líquido ao redor do pulmão)
- **Falha do tratamento** em casa, sem melhora em 48 a 72 horas

Internar não significa que algo foi feito errado — significa que a criança precisa de um suporte que só o hospital oferece.

Como ajudar em casa



Antibiótico no horário, até o fim

Não interrompa quando a criança melhorar. Se vomitar logo após a dose, avise o médico.



Ofereça líquidos com frequência

Água, leite materno ou fórmula em pequenas quantidades e mais vezes ao dia.



Alimente em porções menores

Refeições fracionadas cansam menos. Aceitar menos por alguns dias é esperado.



Controle a febre conforme prescrito

Antitérmico na dose e no intervalo indicados. Observe como a criança fica quando a febre baixa.



Deixe descansar e observe

Repouso à vontade, ambiente arejado e livre de fumaça de cigarro.



Lave o nariz com soro fisiológico

Ajuda a respirar e a se alimentar melhor, principalmente em bebês.

Evite: xaropes para tosse — a tosse é o mecanismo que ajuda a limpar o pulmão — e qualquer medicação por conta própria. Terapias complementares, como a fisioterapia respiratória, devem ser indicadas e ajustadas pelo médico que acompanha a criança.

Quando procurar o pneumologista pediátrico



Um episódio único, com boa recuperação, costuma ser acompanhado pelo próprio pediatra. A avaliação do especialista é recomendada quando:

- A pneumonia foi **complicada**: derrame pleural, empiema, abscesso ou necrose
- Houve necessidade de **UTI, oxigênio prolongado** ou ventilação
- É a **segunda pneumonia no ano** ou a terceira ao longo da vida
- As pneumonias acontecem **sempre no mesmo lugar** do pulmão
- Ficaram **sintomas persistentes**: tosse por mais de 4 semanas, chiado, cansaço aos esforços
- Há suspeita de **causa de base**: asma, refluxo, engasgos, imunidade baixa, fibrose cística ou malformação
- A criança é **prematura** ou tem doença pulmonar prévia

Se a criança teve alta hospitalar, **agende a reavaliação ainda nas primeiras semanas**, mesmo que ela pareça bem. É nesse período que se define se algo mais precisa ser investigado.

O valor do acompanhamento



Encontrar a causa por trás

Pneumonias repetidas costumam ter um motivo: asma, engasgos e refluxo, defesa imunológica baixa, malformação ou até um objeto aspirado.



Detectar sequelas cedo

Infecções graves podem deixar áreas de pulmão danificadas, como bronquiectasias. Quanto antes identificadas, melhor o controle.



Proteger o crescimento do pulmão

O pulmão continua se desenvolvendo na infância. Evitar novas infecções preserva a função respiratória do adulto que essa criança vai ser.



Evitar exames desnecessários

O especialista organiza a investigação, pedindo o exame certo na hora certa — e evitando repetições de imagem sem necessidade.

Sobre a radiografia de controle: em crianças previamente saudáveis e com boa recuperação, repetir o raio-X de rotina **não é necessário**. Ele é indicado quando houve complicação, sintomas persistentes ou pneumonias de repetição.

Leve à consulta os exames e relatórios da internação.

Como reduzir o risco



- ✓ **Vacinas em dia:** pneumocócica, influenza, Haemophilus tipo b, coqueluche e covid-19 conforme o calendário
- ✓ **Amamentação**, quando possível, protege contra infecções respiratórias
- ✓ Casa **livre de fumaça** de cigarro, inclusive no varandão e no carro
- ✓ **Lavagem de mãos** e etiqueta da tosse em toda a família
- ✓ Evitar contato próximo com pessoas gripadas no período de maior circulação de vírus

Guarde estes três pontos

- ✓ Febre e tosse com **respiração rápida** pedem avaliação médica.
- ✓ Espere melhora em **48 a 72 horas** de antibiótico — mas a tosse demora mais.
- ✓ Esforço para respirar, lábios roxos ou recusa de líquidos: **pronto-socorro**.

Na dúvida, procure o pediatra
que acompanha o seu filho.



Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751

RQE 6271

Este material tem finalidade **educativa** e não substitui a consulta médica, o diagnóstico ou o tratamento indicado para o seu filho.

Conteúdo baseado no documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre pneumonias adquiridas na comunidade, nos parâmetros da OMS e em diretrizes brasileiras de pneumologia pediátrica.